

Tiểu đêm (nocturia) là tình trạng thức giấc một hoặc nhiều lần trong đêm để đi tiểu. Đây là vấn đề rất phổ biến, đặc biệt khi tuổi cao, nhưng bạn không nhất thiết phải chấp nhận nó — tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ, gây mệt mỏi ban ngày và tăng nguy cơ té ngã. Hầu hết nguyên nhân đều có thể điều trị được khi xác định đúng.

Về tình trạng này

Có ba nguyên nhân chính khiến người ta thức giấc để đi tiểu, và nhiều người có **kết hợp** nhiều nguyên nhân:

- **Sản xuất quá nhiều nước tiểu về đêm** (đa niệu ban đêm) — do uống nhiều dịch buổi tối, caffeine hoặc rượu bia, phù chân, vấn đề tim hoặc thận, ngưng thở khi ngủ, hoặc thuốc lợi tiểu.
- **Bàng quang chứa ít hơn bình thường** — do bàng quang tăng hoạt hoặc tuyến tiền liệt phì đại.
- **Giấc ngủ bị gián đoạn** — bạn thức giấc vì lý do khác rồi mới đi tiểu.

Tại sao cần quan tâm

Ngoài việc mất ngủ, thức dậy ban đêm là nguyên nhân hàng đầu gây **té ngã và gãy xương** ở người lớn tuổi. Vì tiểu đêm thường là dấu hiệu của một vấn đề có thể điều trị (và đôi khi liên quan đến ngưng thở khi ngủ hay bệnh tim), cần được đánh giá thay vì bỏ qua.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu đêm

Thức giấc để đi tiểu ban đêm.

Đa niệu ban đêm

Sản xuất phần lớn lượng nước tiểu trong ngày vào ban đêm.

Nhật ký tiểu tiện

Ghi lại thời điểm và lượng nước tiểu cả ngày lẫn đêm.

Bàng quang tăng hoạt

Bàng quang phát tín hiệu tiểu gấp và chứa ít hơn bình thường.

Ngưng thở khi ngủ

Rối loạn hô hấp khi ngủ, có thể làm tăng lượng nước tiểu ban đêm.

Desmopressin

Thuốc giúp giảm lượng nước tiểu ban đêm ở một số bệnh nhân.

BƯỚC ĐẦU TIÊN: NHẬT KÝ TIỂU TIỆN Ghi lại **nhật ký tiểu tiện** trong vài ngày — ghi thời điểm và lượng dịch bạn uống cũng như lượng nước tiểu, cả ngày lẫn đêm — là việc hữu ích nhất bạn có thể làm. Nhật ký giúp nhóm chăm sóc xác định **nguyên nhân nào** gây ra tiểu đêm để chọn đúng hướng điều trị.

Chẩn đoán như thế nào

- **Nhật ký tiểu tiện** và xem xét thói quen uống nước, thuốc đang dùng, giấc ngủ
- **Xét nghiệm nước tiểu** và kiểm tra tuyến tiền liệt phì đại hoặc bàng quang tăng hoạt
- Tầm soát **phù chân, ngưng thở khi ngủ** hoặc nguyên nhân từ tim/thận khi cần

Điều trị như thế nào

- 1 **Thói quen buổi tối** — hạn chế dịch, caffeine và rượu bia trong 3–4 giờ trước khi ngủ.
- 2 **Với phù chân** — kê cao chân buổi chiều, mang vớ nén và uống thuốc lợi tiểu sớm hơn trong ngày (theo chỉ định).
- 3 **Điều trị nguyên nhân từ bàng quang** — bàng quang tăng hoạt hoặc tuyến tiền liệt phì đại.
- 4 **Thuốc đặc hiệu hoặc điều trị giấc ngủ** — ví dụ: desmopressin khi thực sự sản xuất quá nhiều nước tiểu ban đêm, hoặc điều trị ngưng thở khi ngủ.

An toàn về đêm

- Dùng **đèn ngủ** và giữ lối đi đến nhà vệ sinh thông thoáng để tránh té ngã.
- Đứng dậy từ từ, đặc biệt nếu đang dùng thuốc huyết áp.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Tiểu ra máu**, rát buốt hoặc sốt (có thể nhiễm trùng)
- Đang dùng desmopressin: **buồn nôn, đau đầu hoặc lú lẫn** (có thể hạ natri máu)
- Phù, khó thở hoặc thay đổi đột ngột về lượng nước tiểu

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Tiểu đêm — thức giấc để đi tiểu — rất phổ biến, gây mất ngủ và tăng nguy cơ té ngã; thường có nguyên nhân điều trị được.
2. Ghi nhật ký tiểu tiện vài ngày là bước đầu tiên quan trọng để tìm nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.
3. Hạn chế dịch buổi tối, kiểm soát phù chân, điều trị nguyên nhân từ bàng quang hoặc giấc ngủ. Phòng ngã ban đêm bằng đèn ngủ và lối đi thông thoáng.